

知道理論， 和在晤談中「看見」， 是兩種能力

情緒焦點治療（EFT）督導的基礎：
理論、原則與督導者角色

依據 Greenberg, L. S., & Tomescu, L. R. (2017). *Supervision Essentials for Emotion-Focused Therapy*. APA. (叢書序 + 第1章)

碩士層級臨床心理學教材 | 所有案例皆為綜合改寫之假想情境

讀完這份資訊圖，你能夠……

1. 說明辯證建構主義，以及 EFT 為何以「處理風格」取代「精神病理」
2. 區分四種情緒類型，並用四項準則判斷
3. 用六大原則分析晤談或督導片段
4. 辨識督導者的三種角色，判斷一致或不一致
5. 評估「督導者當諮商者」的界線
6. 兼顧共同情緒核心與文化表達規則
7. 用「可以做」而非「對錯」給矯正性回饋

怎麼用

每一頁先看標題與框線重點（3 秒），再細讀內文。搭配練習 E1–E8 與工作單 A、B。

督導是一門獨立的專業

好治療師 ≠ 好督導者

叢書序指出，督導是「獨立的專業活動」，無法只靠講授學會。

幾乎人人都會當督導者

Rønnestad 等人（1997）的調查顯示：85%–90%的治療師在執業頭 15 年內會擔任督導者。

「帶著心的非專家專家」

叢書主編這樣形容本書的督導者：精確訓練技能，同時尊重並合作。

對碩士生的意義

你現在被督導的經驗，就是你未來督導別人的原型。

懂得「次發情緒」的定義， 卻聽不出個案語氣那一下的轉變？

這正是本書要處理的落差：概念知識不會自動變成晤談中的知覺與回應。

本書的目標

提出第一個清楚界定的 EFT 督導模式：以事件為本位、用任務分析發展，給督導者與受督者一張「督導地圖」。

兩個基本原則

督導和治療一樣，建立在關係與工作之上：建立同盟、確認焦點、辨識標記、介入、確認解決。

督導在做什麼

逐刻看錄影，培養看、聽與同理的技能。

什麼是督導？

Bernard & Goodyear 的定義：由專業中較資深者，提供給較資淺同業的介入。

這段關係……

- 具評鑑性與階層性
- 會持續一段時間
- 是一種有獨特技能的介入

同時有三重目的

1. 提升受督者的專業功能
2. 監督個案接受的服務品質
3. 為專業把關（守門）

容易忽略

督導者對受督者個案的照護品質負有倫理與法律責任；形成性評量是督導的基礎。

好的督導建立在這些假設上

APA 《健康服務心理學臨床督導指引》（2014）的基本假設（改寫整理）

- 需要正式教育與訓練
- 以個案福祉與保護大眾為優先
- 聚焦受督者的能力發展
- 督導者要具備相應能力
- 以實證為基礎
- 關係要建立、維持、必要時修復
- 雙方都有責任
- 整合多元文化

- 受價值、態度與偏見影響
- 遵守倫理與法律
- 採發展與優勢取向
- 需要反思與自我評估
- 雙向回饋
- 評量能力的習得
- 發揮守門功能
- 不同於諮詢、個人治療與師徒指導

情緒焦點治療 (EFT)

一種具實證支持、以歷程為導向的新人本主義經驗取向。

人本原則

經驗的中心性、自我決定、成長傾向

情緒理論

與生俱來的情緒系統，是適應與意義的基礎

辯證建構主義

感受是在多重歷程互動中被建構出來的

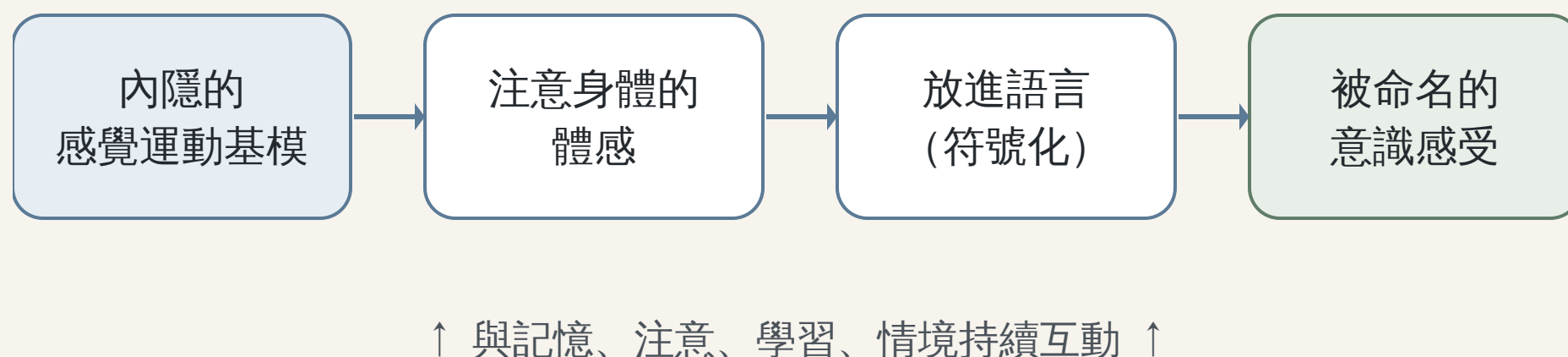
治療的目標

對情緒的覺察、調節、表達、轉化與反思，最終理解情緒、創造新意義、強化自我。

容易誤解

EFT 不等於「讓個案大哭一場」。重點是情緒被處理的方式。

感受是被「建構」出來的



情緒不是完整地躺在潛意識裡，而是以前語言的形式存在（Lane, 2008），經由注意與命名，成為意識到的感受。

臨床上要問什麼？

我的措辭是在幫他找到字詞，還是替他決定感受？治療師的回應本身，就參與了感受的建構。

人是動態的自我組織系統

情緒是基本資料

情緒是人類經驗的基本資料；
意義建構用來理解情緒。情緒
與認知密不可分。

不斷重組的自我

人持續重組「情境中的自我」，而且是能動者：能引導
注意、建構意義。

說故事的人

人持續創造依狀態而變的敘
事，來理解自己與處境。

多重聲音

人有多種聲音、多個故事，情
緒狀態也會快速轉換。

最佳適應

把理性與情緒整合起來：用敘事理解情緒。

先抵達，才能離開

接納經驗，是改變的前提。

原教材：個案必須先接納自己是誰，改變才可能發生（p. 6）。

✗ 急著推離開

「我知道不該依賴他，這週就改掉！」

→ 陪她擬行為計畫

✓ 先協助抵達

「好像很急著不要依賴……那份依賴裡，是什麼在需要他？」

臨床上要問什麼？

我是在協助他抵達這份感受，還是在推他離開？督導中也一樣：受督者先被理解，才能學習。

不是生病，是處理風格卡住了

原教材列出的五種機制	在晤談中可能看起來像……
① 非適應性情緒被激發	一被批評，就湧起童年被羞辱時的羞愧
② 意義建構過度僵化	「沒回訊息 = 我被討厭」
③ 經驗與表達不一致	笑著描述被背叛
④ 無法符號化與表達	「我不知道，就是很悶」
⑤ 自我對立部分難以整合	一邊想離職，一邊斥責自己軟弱

容易誤解

「不看病理」≠「不評估風險與疾病」。這是介入層次的視角，可以與正式診斷並行。

情緒基模與敘事認同

情緒基模

隱含、較高層次的情緒經驗組織，會產生經驗，也會產生行動。多個基模共同作用，形成一個統一的自我組織。

例：憂鬱的基模常圍繞失落、不被愛、無價值或無能。

敘事認同

比情緒基模更高一層的自我組織。敘事起初是非語言、意象式的，隨時間展開；有開始、中間、結尾，也有主角與情節。

一句話區分

情緒基模 = 感受怎麼被組織；敘事 = 這些感受被說成什麼故事。
EFT 兩者都處理。

EFT 督導永遠有兩個焦點

① 個案

協助受督者辨識個案主要的痛苦情緒基模，發展更一致的敘事。

② 受督者

持續關注受督者對個案的情緒反應，形成一致、整合的專業認同。

同樣的人觀，也用在受督者身上

- 治療中出現困難時，不以受督者的人格評價
- 同盟出問題時，不視受督者為病理
- 督導者真誠承擔「問題共同建構者」的責任

容易誤解

「我就是太內向」是人格化歸因。應改問：那一刻發生了什麼歷程？

EFT 的六大原則

同時形塑治療與督導。

1 跟隨與引導

2 同理探索回應風格

3 歷程診斷，而非人的診斷

4 促進更深的情緒經驗

5 學習與教導知覺技能

6 情緒與需求跨越文化

重要界線

EFT 的失功能理論與治療理論不套用在受督者身上。督導促進學習，不在督導中治療受督者。

跟隨與引導：不是矛盾，是辯證

跟隨（內容）

逐刻跟隨內在經驗，「手指放在情緒脈搏上」。個案是經驗的專家。

引導（歷程）

治療師是「情緒教練」：不是個案經驗的專家，而是促進下一步的專家。

歷程引導的三個方向

- 活化更深的經驗與更適應的回應
- 進行晤談中的任務（例：未竟事務）
- 朝向整體治療目標

在督導中

受督者最了解個案與自己；督導者是歷程專家，不是受督者經驗的權威。

同理探索：主動投入，但試探

以投入但試探性的語氣，做探索性的反映或提問，激發對方自己的理解與意義追尋。

在治療中

「好像有一點什麼……是失望嗎？還是別的？」
讓個案比對字詞是否貼切。

在督導中

督導者拒絕「由專家獨自決定要處理什麼」，與受督者**共同建構**歷程概念化、督導目標與意義。

臨床上要問什麼？

這句話是從對方的參照架構出發，還是從**我的**？

歷程診斷，而非人的診斷

注意的是個案的處理風格、晤談中的標記、主要主題，並追隨情緒痛苦。

標記 (marker)

晤談中的行為，顯示個案已準備好處理某個問題。

任務 (task)

因應標記、與個案合作展開的晤談內程序。

例：對重要他人揮之不去的負面感受 = 未竟事務標記 → 空椅對話，處理受傷與憤怒。

在督導中

同樣辨識督導標記，依受督者的需要協議要處理的任務。

促進更深的情緒經驗

假設：更深的經驗與生產性的情緒處理，會帶來新意義，最終走向解決。

治療師提供的專業

如何深化經驗；如何覺察、取用、處理並轉化情緒；如何創造新意義。

督導者的角色

首先是訓練者。協助受督者認出深化的時機與任務，並給逐刻回饋：這一句可以怎麼回。

容易誤解

EFT 督導不只是「討論個案概念化、擬定治療計畫」，更是一句一句地練回應。

知覺技能：知道「何時」

介入技能

知道如何介入

知覺技能

知道何時介入；能在現象出現的當下注意到它

概念知識讓人「理解」，卻不一定讓人「能在情境中應用」。受督者需要具體例子，才能做出必要的知覺區辨；督導會依受督者的程度調整。

怎麼學？

在錄影中，於現象出現的當下暫停，被指出：「就是這裡。」

情緒核心相通，表達規則不同

共同的需求

生存、成長、依附與歸屬、被重視與被認可

不同的規則

表達與溝通情緒的方式，屬於不同的信念、習俗與態度

原教材例：集體主義文化的個案，可能較難對父母或權威表達憤怒。良好的同盟與同理，能隨時間抵達情緒核心。

取得文化知識的途徑：教育、好奇、直接經驗、開放態度。

批判提醒（延伸）

普世情緒觀是理論前提。「覺察」不等於「必須表達」，是否表達、如何表達，由個案決定。

最關鍵的知覺技能： 區辨四種情緒

原發適應性

對當下的直接反應，助人行動

原發非適應性

過度學習的反應，干擾功能

次發反應性

對反應的反應，遮蔽原發

工具性

表達出來以影響他人

怎麼教

督導者在錄影中當場指出例子，並討論它在那一刻的功能。

原發適應性情緒

自動處理情境資訊後產生，直接針對當下情境，讓人準備採取有效行動。

處理方向：取用並允許

協助它被更充分地經驗，以提供資訊與行動傾向。治療師像「代理資訊處理者」，提供字詞讓個案比對。

示範用語（原教材）

「這是你最底層、最核心的感受嗎？」

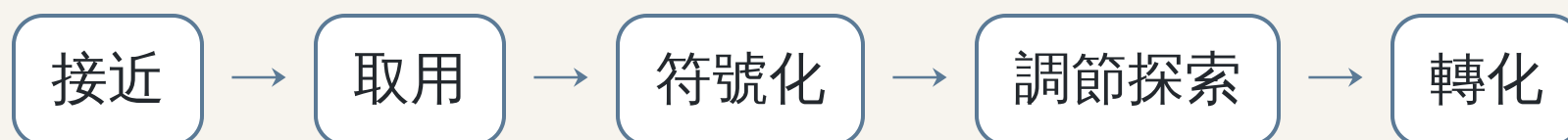
「往內檢查看看，這是不是你最基本的感受？」

辨認線索（延伸）

與情境相稱；說出來之後，更清楚、有方向。

原發非適應性情緒

也是直接反應，但已無法幫助人建設性地因應；通常是基於過去（常為創傷性）經驗的過度學習反應。



以情緒轉化情緒

例：以自我慈悲或自豪轉化非適應性的羞愧。被接納而非逃避之後，情緒才能被轉化。

辨認線索（延伸）

「又來了」的熟悉感；強度與情境不相稱；說出來後更卡住。

次發反應性情緒

「對反應的反應」

跟在原發反應之後，取代並遮蔽原本的情緒，帶出不完全適合當下的行動。

常見樣貌

對悲傷的憤怒

對害怕的羞愧

無望、絕望

處理方向

同理探索，找出底下的原發情緒。

例：反應性憤怒底下的恐懼。

容易誤解

不是每一份憤怒都是次發的。看功能，不看情緒名稱。

工具性情緒

被表達出來，以影響他人，具有人際功能或意圖。

處理方向：探索它的人際功能

「我在想，你是不是想藉著這份感受，向這個人表達某個重點、告訴他某件事？」

這讓人能認出情緒中的意圖：保護自己、得到安慰，或支配他人。

容易誤解

工具性情緒 ≠ 操弄。道德化的標籤會破壞同盟；原教材的做法是好奇地探索。

情緒評估的四項準則

① 非語言表達

臉部表情、語調，以及事情是怎麼被說出來的

② 普世情緒反應

被侵犯通常會生氣；失去重要他人通常會悲傷

③ 自己的情緒反應

用受督者或治療師自身的反應作為參照

④ 個案的特徵模式

例：被忽視時，先覺得渺小，再轉為無望

交叉使用（延伸）

只靠③容易投射，只靠②會忽略文化差異。最終的檢驗是：個案對試探性同理的反應。

同一份「憤怒」，四種可能

類型	可能的情境	回應方向
原發適應性	同事搶功，堅定地說「那是我做的」	驗證並允許，讓它提供行動方向
原發非適應性	小事就全面爆發；「每次都這樣」	接近、符號化，再轉化
次發反應性	被當眾糾正後的不爽，底下是難堪	同理探索底下的原發情緒
工具性	「不兇他們就不會聽」	好奇地探索人際功能

一句話

先判斷情緒此刻的功能，再決定要深化、轉化、往下探，還是探其目的。

EFT 任務的五大類別

同理本位

關係

經驗

再處理

演出

具體的標記與任務在第3章展開（見單元3）。

「可以做」，不是「對或錯」

早期把介入當作實驗，先試探性地嘗試，再逐漸熟練、流暢。督導者的建議是提供可能性，不是宣判對錯。

個人化／整合技能

依自己的風格與人格，逐步採納並整合介入。

EFT 從哪裡來？

1960–70 年代，行為主義與精神分析之外的「第三勢力」：

個人中心

Rogers：關係是價值條件的解藥，讓人被看見、被理解、被接納。

Gendlin：經驗與體感。

完形

自我實現傾向；需求自發浮現；歷程指導風格；以分級實驗為介入。

存在

終極關懷：自由、選擇、孤獨、意義；存在焦慮。

EFT 的整合

完形的歷程指導 + 強化情緒與覺察；個人中心的安全感與分化經驗、建構意義。

EFT 超越源流的地方

源流	EFT 怎麼修改它
個人中心	Rogers 與 Gendlin 以經驗為基本資料；EFT 以情緒為基本前提，經驗是多層處理合成的衍生物
完形	保留實驗，但更清楚界定每個實驗何時最適合使用、促進哪些改變歷程
存在	除了自由、孤獨、意義，也把情緒的調節與符號化視為終極關懷

體感需要被注意並符號化，才能產生意義；基本情緒（恐懼、憤怒、悲傷）需要被喚起並調節，才能取用需求與行動傾向。

督導者的三種角色

EFT 督導三者都採用，但各有界線。

教師

決定受督者需要什麼知識才能更勝任。

EFT：更精確地說是訓練。

諮商者

協助探索受督者的人際或內在現實。

EFT：有限度。

顧問

作為資源，鼓勵受督者信任自己的想法與感受。

臨床上要問什麼？

此刻受督者需要的是哪一種？跟隨與引導，各有其時。

教師角色：大量引導， 但顧及關係安全

EFT 對特定的晤談標記有高度發展的技能，所以督導有很多教學與矯正性回饋。許多技能必須在實際臨床情境中學。

督導的藝術

讓矯正性回饋被感受為支持，而非批評。

✗ 「這裡錯了，應該反映悲傷。」

✓ 「停在這裡。她的聲音變了……這一刻可以做的有好幾種。」

秘訣

督導者以好奇的探索者自居，而不是全知的專家。

諮商者角色：督導不是治療

受督者的個人阻礙影響治療能力時，督導者可在限度內提供支持性諮商。

1 先同理，詢問是否願意探索

2 理想上只做一次

3 事件本位，不是持續性的

4 不超過受督者的自在程度，也不超過關係能承受的程度

第 5 條

需要更深入時，轉介給治療師。督導契約不含個人治療。

顧問角色：信任受督者自己

促進自我效能

以受督者的優勢與天賦為基礎，鼓勵他信任自己對個案的感受與想法。

資源提供者

必要時提供知識與資訊。

在示範與鼓勵受督者信任自己之間取得平衡；有時也擔任受督者自身晤談經驗的歷程促進者。

示範也是教學

尊重、同理、真誠、合作解決問題：督導者怎麼對待受督者，本身就在教。

一致的督導事件 vs. 不一致的督導事件

一致：受督者的需要與督導者的回應相符。條件是理論取向相符、任務相關、雙方投入、目標有共識。

✓ 一致（原教材例）

新手受督者說對下次晤談有籠統的擔憂 → 督導者跟隨，協助深化、命名並理解它。

✗ 不一致（原教材例）

受督者在概念化上卡住 → 督導者直接給診斷，取代了促進概念化的歷程。

臨床上要問什麼？

我心裡已有答案，就應該先說出來嗎？

專家與共構者的辯證

督導者的權力

擁有技能與經驗；在評鑑層次決定表現是否適當。仍對受督者與個案負責。

合作的姿態

有興趣地投入、平等。先問受督者，個案此刻的感受是什麼。

從專家位置傳遞知識，但不羞辱、不強加價值或解法；共構目標，並管理權力的平衡。

承認錯誤（原教材示範）

「我想我剛才說的不對；我現在明白你對個案感受的看法了。」

督導者實際在做什麼？

把受督者當成改變的能動者，提供 Rogers 的三條件：同理、一致、無條件正向關懷。

- 同理探索、對話
- 示範、角色扮演
- 經驗學習、歷程引導
- 把未被承認的議題帶進討論

- 一起看錄影，需要時暫停
- 舉好與不好的介入為例
- 給補知識的作業
- 請受督者練習回應

有治療阻礙時

督導者會深化受督者的經驗，但仍守住諮商者角色的界線。

兩位作者如何成為督導者

Greenberg

以態度訓練（Rogers）整合技能訓練（Carkhuff）；重視錄影與現場督導；不用面質。後來越來越技術導向，並轉介受督者做個人治療：處理自己的情緒，能擴大處理他人情緒的能力。

Tomescu

在威權、懼於表達的環境中長大，因此特別珍視不強加、合作的督導。受督者需要勇氣，也要覺察權力差距與失調的破壞性。

帶給我們的提醒

較具指導性的督導，需要先有接納與肯定的關係框架。

改變從哪裡開始

「個案必須先抵達一個地方，
才能離開那個地方。」

“the client has to arrive at a place before he/she can leave that place”

臨床意義

接納經驗是改變的前提。未被觸及的情緒，無法被轉化。

教學重點

自我檢核：我在協助抵達，還是在推他離開？

回饋的藝術

「督導的一部分藝術，在於以讓人感受為支持而非批評的方式，給予矯正性回饋。」

“...giving corrective feedback in a manner that is felt as support rather than criticism.”

臨床意義

技術回饋能否被吸收，取決於關係與方式。

教學重點

受督者可以期待並請求；督導者要刻意練習。

歷程，而非病理

「個案不被視為經驗著精神病理，
而是擁有一種功能不良的
情緒處理風格。」

“clients are not seen as experiencing psychopathology, but rather as having a dysfunctional style of emotional processing.”

臨床意義

焦點轉向可介入的歷程；也用
來理解受督者。

批判思考

在需要診斷、風險評估與醫療
協作時，它的限度在哪裡？

六個最常見的誤解

常見理解	更精確的臨床理解
憤怒底下一定有悲傷	看功能：有些憤怒是原發適應性的
工具性情緒 = 操弄	好奇地探索它的人際功能
不看病理 = 不評估風險	風險評估永遠另外進行
支持性督導 = 不給批評	大量回饋，重點是怎麼給
懂理論就能看見標記	知覺技能要在錄影中被指出
沒表達憤怒 = 沒有憤怒	可能是文化表達規則

「她哭，是想博取同情，所以我刻意不回應。」

✗ 錯在哪裡

未經探索就認定是工具性情緒；忽略眼淚；把情緒道德化，破壞同盟。

✓ 修正後的推理

① 先同理她的難過 → ② 觀察：說出來後是更清楚，還是更卡住？ → ③ 若有人際功能的線索，好奇地問：「這份眼淚，想告訴誰什麼？」

同時考慮

次發（遮蔽其他情緒）？原發（真實的失落）？至少保留兩個假設。

檢查一下你記住了什麼

Q1 「我氣死自己了，一直哭，很沒用。」這份生氣最可能是哪一類情緒？

Q2 每次被指正小錯，就湧起熟悉的「我是廢物」的羞愧，而且整天無法工作。是哪一類？該怎麼處理？

Q3 受督者卡在概念化上，督導者說：「她就是邊緣型人格，照這個做。」這是一致還是不一致的督導事件？

Q4 個案說「我這週就要改掉依賴」。依「先抵達，才能離開」，第一步是什麼？

解答與一句話說明

A1 次發反應性。這是對悲傷的憤怒，也就是「對反應的反應」。同理探索底下的悲傷。

A2 原發非適應性。熟悉、過度學習、干擾功能。先接近、符號化，再以自我慈悲轉化。

A3 不一致。督導者以專家身分直接下診斷，取代了促進概念化的歷程。

A4 先協助她接觸依賴裡的感受與需要，而不是先擬定改變計畫。

更多練習：E1 情境選擇題、E2 區辨與分類。

阿哲：同一份憤怒的四種可能

34 歲工程師，被主管當眾說程式「像實習生寫的」。音量提高：「他憑什麼？」停頓兩秒、低頭，接著說：「反正他們就是看不起工程師。」

四項準則交叉

①低頭、停頓 ②被當眾貶低，通常難堪又生氣 ③治療師感到心疼 ④父親常說「做不到就是廢物」

暫定概念化

羞愧為核心，憤怒是次發；但也包含對不尊重的適應性不滿。

下一步

先驗證憤怒，再輕輕轉向低頭那一刻：「那時候心裡好像有點什麼？」

小安：督導者心裡已有答案

碩二實習生說：「都可以……其實我沒什麼頭緒。」笑了一下，手捏著筆。錄影裡，她在個案哭時兩度轉移話題。期中評量快到了。

✗ 不一致

「核心是被遺棄恐懼，你去做空椅。」

✓ 一致

「你說卡住了……我們從那份卡住開始？她哭的時候，你心裡發生了什麼？」

重點

顧問 → 有限度的諮商者 → 以「可以做」教學；主動處理評量帶來的權力差距。

林太太：「照顧婆婆是應該的」

47 歲，照顧失智婆婆三年，失眠、「常常莫名想哭」。說「應該的」時面帶微笑，下巴微繃、輕嘆一口氣。

假設

未被符號化的委屈或悲傷（經驗與表達不一致）
也可能是真實認同照顧的價值，而身心耗竭

做法

先驗證她的價值 → 試探地反映嘆氣 → 給予許可但不強加表達

文化提醒

目標是協助覺察，不是要求她向婆婆或先生表達不滿。也要評估照顧負荷與憂鬱。

評估一個情緒的八個步驟

1 我知道什麼？

2 我還不知道什麼？

3 我的類型假設？

4 替代解釋與文化？

5 四準則怎麼說？

6 下一句試探回應？

7 什麼會改變判斷？

8 依類型定方向

受督者版

同樣八步，用來反思「我在晤談中卡在哪裡」，並帶一個標記進督導（見工作單 B）。

這對實務意味著什麼？

面向	本單元的意涵
評估	除了「什麼疾患」，也問「此刻情緒如何被處理」
概念化	區分表層的次發情緒與底層的原發情緒
介入	標記引導任務；先抵達，才能離開
關係	個案是經驗專家，治療師是歷程專家
風險	永遠另外評估，歷程診斷不能取代
督導	雙重焦點；錄影；不以人格評價；承認錯誤

哪些主張有證據？

主張	證據性質
EFT 具實證支持	本章只有背景陳述；研究在第6章
情緒以前語言的基模存在	引用 Lane（2008）
情緒與需求普世相通	理論前提，本章未引研究
85%–90%治療師會當督導者	調查研究（1997，歐美樣本）
督導者的養成經驗	作者自述，不是研究證據
本督導模式有效	尚待驗證（作者於第7章承認）

還沒有答案的問題

1. 「不看精神病理」，在精神病、物質使用或急性風險時的限度在哪裡？
2. 普世情緒觀會不會把特定文化的「自我肯定」當成普世目標？
3. 督導者同時是評分者時，「合作與平等」如何真正做到？
4. 作者不用面質；面對危險行為時，是否需要更直接的回饋？
5. 同理，可以被「教」嗎？（態度訓練 vs. 技能訓練）

四個層次的學習

必須記住

六大原則、四種情緒、四項準則、五種機制、三種角色、五類任務

必須理解

感受如何被建構；為何先抵達；知覺 vs. 概念知識；督導不是治療

必須能夠應用

判斷情緒類型並選擇回應；辨識一致與不一致的督導事件；用「可以做」給回饋

必須能夠質疑

病理觀的限度；普世情緒的文化限制；權力與合作；缺乏直接實證

搭配練習與工作單

時機	建議使用
課前	E1 情境選擇題；工作單 A（概念整合）
課中	E2 區辨分類；E4 督導逐字稿；E6 三人角色扮演
課後	E3 找錯；E5 情緒評估撰寫；E7 漸進概念化；E8 反思
實習中	工作單 B：用去識別的片段，帶一個標記進督導

工作單 A 與 B 的差別
A 建構概念架構；B 把概念應用到案例上，並做出決策。

督導與治療一樣： 改變，發生在被理解之後。

主要來源：Greenberg, L. S., & Tomescu, L. R. (2017). *Supervision Essentials for Emotion-Focused Therapy*. Washington, DC: American Psychological Association. 叢書序 (pp. vii–xii) 與第1章 (pp. 3–27)。

本資訊圖的表格與列表皆經改寫整理，引文為短句並附頁碼。原書案例已由作者改寫以保密；本資訊圖的案例皆為綜合改寫之假想情境。標示「延伸」者為本教材的補充，不是原書主張。

下一單元：EFT 督導模式的基本向度（第2章）